Quy cách làm tờ rơi và tờ bướm

Tài liệu truyền thông giáo dục sức khỏe

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN — PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Bản hướng dẫn đề xuất để thống nhất biên soạn, thiết kế và kiểm tra bản in. Áp dụng cho tài liệu cung cấp người bệnh và người chăm sóc. Các thông số trình bày dưới đây là lựa chọn nội bộ đề xuất; không phải quy cách bắt buộc chung do Bộ Y tế ban hành.

1 Chọn loại tài liệu

Loại	Cách dùng	Khổ đề xuất
Tờ rơi	Một tờ không gấp, in một hoặc hai mặt; tập trung một chủ đề và vài hành động chính.	A5 đứng 148 × 210 mm; có thể dùng A4 đứng 210 × 297 mm khi cần chữ lớn.
Tờ bướm gấp đôi	Một tờ gấp thành hai phần, tạo bốn ô; thích hợp nội dung ngắn và hình lớn.	A4 ngang 297 × 210 mm, gấp thành khoảng 148,5 × 210 mm.
Tờ bướm gấp ba	Một tờ gấp ba, tạo sáu ô, in hai mặt; có bìa và các phần nội dung.	A4 ngang 297 × 210 mm; kích thước ô phụ thuộc kiểu gấp, xem sơ đồ trang 3.

Chọn khổ theo người đọc và lượng thông tin. Không thu nhỏ chữ để nhét bài dài; cắt nội dung phụ, tăng khổ hoặc chuyển sang bài hướng dẫn riêng. Không gọi sáu ô của tờ bướm là sáu tờ giấy.

Mục tiêu trước khi thiết kế

Ghi rõ đối tượng, một thông điệp chính và việc mong người đọc thực hiện. Với người cao tuổi hoặc giảm thị lực, ưu tiên bản khổ lớn, chữ lớn và hướng dẫn trực tiếp. Bản điện tử hoặc QR không thay thế hỗ trợ cho người không dùng điện thoại.

Mã và phiên bản chính thức sau phê duyệt .....

Ngày áp dụng .....

Người biên soạn, rà soát và phê duyệt .....

2 Chữ màu sắc hình ảnh và khoảng cách

Thành phần	Quy cách đề xuất
Phông chữ	Arial hoặc phông không chân hỗ trợ đầy đủ tiếng Việt. Dùng một họ chữ, tối đa hai họ nếu cần; tránh chữ trang trí cho nội dung.
Tên chủ đề	Khoảng 22–28 pt với A5 hoặc ô tờ bướm; 26–36 pt với A4. Cho phép xuống dòng, không kéo dãn chữ.
Tiêu đề mục	Khoảng 15–18 pt, in đậm, phân cấp nhất quán.
Nội dung chính	Tối thiểu 12 pt; ưu tiên 13–14 pt khi có thể. Người cao tuổi nên thử 14–16 pt, điều chỉnh khổ và lượng chữ theo khả năng đọc thực tế.
Nguồn và thông tin kiểm soát	Khoảng 9–10 pt nếu vẫn đọc rõ; không dùng cỡ này cho hướng dẫn chăm sóc, cảnh báo hoặc số điện thoại cần sử dụng.
Giãn dòng và căn lề	Khoảng 1,15–1,3 dòng; căn trái, đoạn ngắn, có khoảng cách giữa các mục. Tránh căn đều gây khoảng trắng lớn trong ô hẹp.
Lề an toàn	Chữ và logo cách mép xén ít nhất khoảng 5 mm; cách nếp gấp khoảng 7–10 mm. Với máy in văn phòng giữ lề theo vùng in thực tế của máy.
Màu sắc	Nền sáng, chữ sẫm; dùng màu đỏ và xanh theo nhận diện Nhật Tân ở mức vừa phải. Không dùng riêng màu để phân biệt cảnh báo.
Logo	Dùng bản gốc được bệnh viện chấp thuận; giữ tỷ lệ, không bóp méo, không tự sửa tên hoặc màu; đặt ở bìa hoặc đầu tờ.
Hình minh họa	Đúng hành động cần hướng dẫn, dễ hiểu, có chú thích nếu cần; bảo đảm quyền sử dụng, riêng tư và không tạo ấn tượng sai về kết quả điều trị.

Thử đọc trên bản in đúng kích thước, không chỉ nhìn khi phóng to màn hình. CDC khuyến nghị chữ nội dung in ít nhất 12 pt [1]; các khoảng cỡ khác trong bảng là đề xuất thiết kế nội bộ.

3 Chia ô và thứ tự tờ bướm gấp ba

Một mẫu gấp cuốn phổ biến: nhìn từng mặt ở chiều đọc bình thường, bìa trước nằm bên phải của mặt ngoài. In bản thử, ghi số ô và gấp thật trước khi duyệt. Nếu đổi hướng gấp thì cần đổi sơ đồ tương ứng.

Mặt ngoài của mẫu gấp cuốn

Ô bên trái	Ô ở giữa	Ô bên phải
5 Cánh gập vào Dấu hiệu cần khám ngay hoặc nội dung bổ sung.	6 Bìa sau Nguồn, liên hệ, phiên bản và QR nếu có.	1 Bìa trước Logo, tên chủ đề, thông điệp và hình chính.

Mặt trong của mẫu gấp cuốn

Ô bên trái	Ô ở giữa	Ô bên phải
2 Hiểu vấn đề Thông tin cơ bản và dấu hiệu cần biết.	3 Việc cần làm Chăm sóc, ăn uống hoặc phòng bệnh.	4 Thực hiện an toàn Theo dõi, dùng thuốc theo chỉ định, việc cần tránh.

Số ô biểu thị thứ tự đọc dự kiến, không phải thứ tự trang PDF. File in có hai trang: mặt ngoài và mặt trong; không xuất thành sáu trang đơn nếu nhà in yêu cầu bản trải hai mặt.

Kích thước ô theo kiểu gấp

Kiểu	Gợi ý chia A4 ngang	Lưu ý
Gấp chữ Z	99 + 99 + 99 mm	Ba ô có thể bằng nhau. Thứ tự bìa phải được thử theo hướng gấp đã chọn.
Gấp cuốn	Mặt ngoài: 97 + 100 + 100 mm Mặt trong nhìn thẳng: 100 + 100 + 97 mm	Cánh gập ngắn hơn để không cấn. Đây là ví dụ; dùng khuôn nhà in theo loại giấy và thiết bị gấp.

Nếp gấp là đường hướng dẫn thiết kế, không in đường đứt nét xuyên nội dung trừ khi có mục đích rõ. Không đặt chữ, mã QR hoặc khuôn mặt trên nếp gấp. Với gấp đôi, mặt ngoài thường là bìa sau bên trái và bìa trước bên phải; vẫn phải in và gấp thử.

4 Nội dung nguồn tham khảo và mã QR

Bố cục nội dung cần có

• Tên chủ đề và thông điệp chính: người đọc cần biết hoặc làm gì.

• Thông tin cơ bản ngắn gọn: bệnh hoặc vấn đề là gì, ai cần lưu ý.

• Hướng dẫn hành động: viết cụ thể, phù hợp từng đối tượng; giải thích từ khó.

• Việc cần tránh và dấu hiệu phải báo nhân viên y tế, đi khám hoặc cấp cứu.

• Tái khám, theo dõi và liên hệ đã được bệnh viện xác nhận.

• Nguồn tham khảo, phiên bản, ngày rà soát và đơn vị chịu trách nhiệm.

Mỗi tài liệu tập trung một chủ đề. Dùng câu ngắn, động từ rõ; không chỉ viết "ăn hợp lý" mà cần ví dụ phù hợp. Thuốc và kỹ thuật phải theo hướng dẫn được duyệt; không ghi liều dùng chung cho mọi người bệnh hoặc quảng bá "chữa khỏi" khi không có căn cứ.

Đặt nguồn ở góc phải phía dưới

Theo quy ước trình bày của bệnh viện đề xuất: tờ rơi đặt nguồn ở cuối mặt sau, phía phải; nếu chỉ có một mặt thì đặt cuối mặt đó. Tờ bướm đặt ở góc phải dưới của ô bìa sau theo chiều đọc, vẫn nằm trong lề an toàn. Không hiểu là bắt buộc đặt ở góc phải của toàn bộ bản trải.

Nguồn ngắn trên bản phát tay gồm cơ quan, tên tài liệu và năm/phiên bản. Đường dẫn dài có thể đặt trong hồ sơ nguồn hoặc trang đích, nhưng phải truy vết được. Vị trí góc phải là quy ước nội bộ, không phải yêu cầu chung của Bộ Y tế.

QR chỉ bổ sung cho nội dung thiết yếu

Dẫn đến tài liệu hoặc trang thông tin đã được phê duyệt, không dẫn tới bản nháp hay thư mục chứa dữ liệu người bệnh. Kích thước khởi đầu đề xuất khoảng 25 × 25 mm, có vùng trắng xung quanh theo đặc tả bộ tạo mã; không chèn hình làm mất vùng mã. Mã chứa nhiều dữ liệu có thể cần lớn hơn.

Ghi rõ quét để xem gì, kèm đường dẫn ngắn khi có. Thử quét từ bản in bằng nhiều điện thoại, kiểm tra quyền truy cập của người ngoài và bố trí người duy trì đường dẫn. Không tạo QR giả hoặc ghi "có QR" khi chưa có địa chỉ đích được xác nhận.

5 Thiết lập file và kiểm tra in

Hạng mục	Quy cách đề xuất và việc cần xác nhận
Kích thước file	Đặt đúng khổ thành phẩm ngay từ đầu. Tờ bướm A4 ngang là 297 × 210 mm, không phải ba trang A4 ghép lại.
Phần tràn lề khi in sát mép	Thông thường đề xuất 3 mm mỗi cạnh nếu nhà in chấp nhận. Nền/ảnh chạy sát mép phải phủ vùng tràn lề. A4 ngang có tràn 3 mm sẽ cần vùng artwork 303 × 216 mm; vùng thành phẩm vẫn 297 × 210 mm.
Dấu xén và nếp gấp	Xuất theo yêu cầu nhà in. Không thêm dấu xén vào bản dùng máy in văn phòng nếu không có công đoạn xén; không tự co bản có bleed cho vừa A4 rồi coi đúng kích thước.
Ảnh và logo	Ưu tiên logo vector; ảnh raster thường hướng tới 300 ppi ở kích thước sử dụng. Không chỉ đổi thông số dpi để coi ảnh thấp chất lượng thành ảnh nét.
Màu và font trong PDF	Dùng cấu hình màu, PDF/X hoặc preset nhà in yêu cầu; không tự khẳng định mọi nhà in bắt buộc CMYK. Nhúng font và kiểm tra dấu tiếng Việt, hình, liên kết.
Giấy	Có thể thử giấy không phủ hoặc phủ mờ khoảng 120–150 g/m² cho tài liệu gấp; lựa chọn theo độ dễ đọc, chi phí, máy in và cách gấp. Giấy dày có thể cần cấn nếp.
In hai mặt	Giữ tỷ lệ 100% khi cần đúng kích thước, tắt thu phóng tự động nếu không phù hợp. Thử lật cạnh ngắn với bản ngang nhưng phải xác minh theo máy/driver bằng một tờ in thử.
Bàn giao	Lưu file chỉnh sửa, PDF in, bản xem điện tử nếu có, nguồn hình và hồ sơ phê duyệt. Dùng tên file có chủ đề, loại tài liệu, phiên bản và ngày.

Ví dụ tên file: NhatTan_DaiThaoDuong_ToBuom_v01_20261016.pdf. Thông số tràn lề, màu, độ dày giấy và kích thước cánh gập phải chốt với nhà in; hướng dẫn Adobe giải thích vai trò khác nhau của lề an toàn và bleed [3].

6 Bảng kiểm trước phát hành và nguồn đối chiếu

□ Xác định đúng người đọc và một thông điệp chính.

□ Nội dung được chuyên khoa kiểm tra, nguồn rõ và còn phù hợp.

□ Có hành động cụ thể, cảnh báo và cách tìm hỗ trợ.

□ Chữ đọc rõ ở kích thước in thật; hình đúng và có quyền sử dụng.

□ Logo không méo; màu tương phản; không có dữ liệu người bệnh trái phép.

□ Đúng khổ, mặt ngoài/mặt trong, thứ tự ô và hướng gấp.

□ Chữ, nguồn và QR tránh mép xén/nếp gấp; QR quét được nếu có.

□ Đã in hai mặt và gấp thử; không đảo đầu, cấn giấy hoặc mất nội dung.

□ Đã thử với người đọc phù hợp; người đọc nói lại được việc cần làm.

□ Đã góp ý, phê duyệt, cấp phiên bản, xác nhận ngày áp dụng và nơi lưu.

Tên tài liệu được kiểm tra .....

Người kiểm tra và ngày .....

Chuyên khoa rà soát .....

Người phê duyệt theo phân cấp .....

Bảng kiểm này là công cụ nội bộ đề xuất, không phải bảng chấm nguyên văn C6.2. C6.2 theo QĐ6858/QĐ-BYT đặt yêu cầu về tài liệu, xây dựng theo lộ trình, góp ý/phê duyệt và đánh giá hiệu quả; không quy định thống nhất mọi cỡ chữ, định lượng giấy hoặc kích thước QR.

[1] CDC. Health Communication Playbook. Khuyến nghị chữ nội dung in ít nhất 12 pt.

https://www.cdc.gov/nceh/clearwriting/docs/health-comm-playbook-508.pdf

[2] CDC. Clear Communication Index User Guide. Thông điệp, ngôn ngữ, hình và bố cục dễ hiểu.

https://www.cdc.gov/ccindex/tool/

[3] Adobe Express. Set custom margins and bleed.

https://helpx.adobe.com/sg/express/web/print-and-export/margin-bleed-crop-marks.html

Đối chiếu nguồn ngày 16/10/2026. Bản trình bệnh viện xem xét ban hành; chưa điền ngày áp dụng hoặc người ký thay cho bệnh viện.